EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 93701
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2024-09-28 13:34:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: NELSON DEL CARMEN HERNANDEZ CACERES			RUN	: 7.395.323-5
F.Nac	: 09-09-1953	Edad	: 71 AÑOS	Género	: Masculino
Dirección	: Crisantemo 1344 Jardines			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 76329853		
Fecha Ingreso	: 2024-09-24	Fecha Egreso	: 2024-09-28 13:34:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R57.9-CHOQUE, NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia respiratoria aguda
- ICC descompensada FEVI 49%
- Edema agudo pulmonar resuelto
2. Infección respiratoria por Parainfluenza
3. FA cRVR
4. Asma Bronquial
5. HTA
6. Insuficiencia Mitral Severa/Insuficiencia Tricúspidea Moderada/ Insuficiencia Aortica Leve
9. Íleo medico resuelto

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I50.0-INSUFICIENCIA CARD?ACA CONGESTIVA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Consulta en SU el 23/09 por cuadro de 1 semana de evolución por cuadro de tos no productiva, disnea a medianos esfuerzos y ortopnea, exacerbada al momento de consultar. Fue manejada en SU con broncodilatación, hidrocortisona y furosemida 40 mg vev. Sin embargo, en el transcurso de la atención se le administró 500 ml solución Nacl 0.9% por considerar que se encontraba deshidratado. En este contexto evoluciona con empeoramiento de su disnea, hipertensión, ingurgitación yugular, taquipnea. Es evaluado por Residente de UCI, quien lo encuentra en regular estado, con FA cRVR, diaforético, mal perfundido a distal y signos de congestión pulmonar, por lo que decide su ingreso a la Unidad. Se inicia manejo con VMNI, terapia depletiva y NTG, expectante progresión a VMI.
Evolución en UCI:
Hemodinamia/Cardiovascular: se inició terapia depletiva asociado a BIC NTG dosis baja por 24 hrs y manejo óptimo de ICC para BH negativos a Neutro. Con PRO BNP aumentado que explica descompensación de ICC. Evoluciona con buena respuesta, persiste con leves crepitos bibasales, normotenso, regular control de Fc, aun no llega a metas.
Ventilatorio: se conecta VMNI continuo al ingreso en modo ST IPAP 14 EPAP 10 bien acoplado FIO2 28% con adecuada mecánica ventilatoria, con buena respuesta gasométrica y clínica, se inician ventanas de alimentación que fueron progresando hasta el destete. Ultimo control de GSA PaFI 452. Se mantiene terapia con corticoide EV y broncodilatadores, con leve clínica obstructiva.
Infeccioso: afebril, parámetros inflamatorios bajos, sin ATB. Panel respiratorio positivo para Parainfluenza del 24/09/24.
Renal: diuresis y función renal conservada. Actualmente tolerando régimen oral. Sin deposiciones desde ingreso, sin signos de alarma abdominal, sin dolor en manejo sintomático de íleo médico.
Tras buena evolución, en condición de continuar manejo en UTI.
Ingresa a UTI el 26.09.24 para continuar manejo médico, se mantiene en buenas condiciones médica, se consolida weaning de VMNI, se mantiene BD y apoyo kinésico, sin mayor conflicto inflamatorio.
Actualmente en buenas condiciones generales, afebril, HD estable, sin O2 adicional, buena mecánica ventilatoria pero aún con secreciones pulmonares, por lo que se plantea opción de hospitalización domiciliaria aceptada por paciente; se presenta a equipo de HODOM y se realiza traslado a domicilio.

PLAN DE MANEJO:

Hemodinamia/Cardiovascular: Se mantiene con terapia depletiva full para BH (-) en ajuste de tratamiento. Cambio BB con bisoprolol, inicio digoxina y ajuste antihiperetensivo (evaluar reinicio entresto según evolución). Mantener anticoagulación.
Ventilatorio: Sin O2 hace 48 hrs. Sin VMNI hace >48 hrs. Aún con terapia broncodilatadora y rehabilitación kinésica, por lo que se plantea HODOM.
Infeccioso: vigilar Peak febriles y parámetros inflamatorios, por ahora sin cobertura ATB. Panel viral positivo para Parainfluenza. Hoy completa aislamiento
Renal: función renal conservada, vigilar ELP. Evitar nefrotóxicos
Metabólico: Refuerzo IR para glicemia dentro de objetivos

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Régimen hiposódico, restricción hídrica máximo 1000 cc/día
3. Furosemida 40 mg/día vo
4. Espironolactona 25 mg/día vo
5. Digoxina 0,25 mg/día vo
6. Bisoprolol 2.5 mg/día vo
7. Dabigatrán 150 mg c/12hrs vo
8. Bromuro ipratropio 2 puff c/6hrs c/AC
9. Continuar manejo HODOM

GONZALO EDUARDO VERA TORRES
MEDICO TRATANTE
16497415-4

JEFE SERVICIO